

Tumeur = prolifération cellulaire excessive aboutissant à une masse cellulaire + ou - ressemblant au tissu d'origine (Adénocarcinome Bactérien ; Croissance + épithélioïde MAIS pas)

→ { Cellules Tumorales + Stroma Tumorale }

Diagnostic Différentiel

- Hémorragies → quantités occasionnelles d'hémorragies de cellules normales
- Cholestase = Hépatite → Origine : cellules/tissu normal MAIS qui s'est vu en bon contact Pas de prolifération, c'est une réaction locale.
- Kyste Dystrophique = Multifocité → Les cholestases, papilles, papilles de kyste/gang... Ici : $\neq$ lésion de l'architecture
- Cystes
- Prolifération inflammatoire
- Hyperplasie → Taille ↑ et nb = cte
- Hyperplasie → NB ↑

Les plaques de l'architecture
 lésion des plaques ; plaques rétro-lesionnelles
 lésion post-lesionnelle

TC + Vascularisation + MEC + Inflammation ... réaction inflammatoire

- Prolifération
- Disproportionnalité { Epithélioïde : Trop peu, rétro, non Squamoïde : Abondant, collé, dans l'architecture épithélioïde
- Vascularisation Mucine Extracellulaire → R^e inflammatoire

- * Induction Angiogénique → VEGF
- 2) Autoeffacement avec signes de nécrose } en fait qu'il se fait
- 3) Invasivité avec signes limitant nécrose
- * Résist à l'Apoptose
- 6) Résist au Système Imm
- 6) Prolifération Abnormal → Tumeurs
- 7) Invasivité tissulaire

Atypies du Noyau

- Anisocaryose : irrégulité Taille Noyau
- ↑ Rapport Nucleo-Cytoplasmique : ⊕ Noyau ⊖ Cytoplasme
- Hyperchromatisme : Noyau sombre car ⊕ condensé ou ↑ NB chromos (Anaplasie)
- Grand Nucleolus / Multinucleation
- Irrégularité de forme et de contour

Cytoplasme

- Anisocaryose : irrégulité taille cellulaire (taille des cytoplasmes)
- Sécrétion Anormale (qualité/quantité)

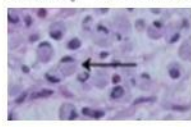
Cytoplaste

- Micronatelle
- Micronatelle d'actine
- Éléments Intracellulaires → Spécifiques de certains cellules

Mécanisme

- Récepteur MBR
- (Né) Anticorps

Cellule "broyée à chair" = Excessivement

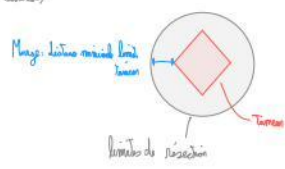


Grade :

- T : Taille / Extension local
- N : "Node" / Extension ganglionnaire loco-région (ganglion central)
- M : Extension Métastases

pTNM = Anaplasie

Qualité de Résection



Reliquat Tumor

- RO : Absence reliquat Tumor = Excision complète
- R1 : Atteint microscopique des limites
- R2 : Atteint macroscopique

Tumeurs

Bénignes

continue "légère agression" "Maligne"

Malignes

Croissance lente	Croissance rapide / Invasives
Bien limitée	Mal limitée
(Positif) Encapsulé	Infiltrant
Peu profond des Tumeurs voisines	Nécrose / Envahissement Tumeurs voisines
Traie différencies (amblable / B)	Les différencies + Bq d'Atypie
Pas de récurrence après Excision complète	Récidive
Pas de Métastases	Métastases

Nomenclature

"Adénome" = glandulaire
 "Kyste" = poche
 "Sarcome" = p. lés

Racine + Suffixe

"-ome" : tumeur **SAUF** (glande) **carcinome**
 "mal" : tumeurs multiples ou diffus
 "carcinome" : Maligne Epithéliale
 "sarcome" : Maligne TC
 "lymphome" : lymphomateux

Phase Pré-cancéreuse

Dysplasies : anomalies génétiques touchant des cellules épithéliales (part partielles de cellules de l'épithélium; atypie...)

△ ne pas confondre avec "métastase" : métastases cellulaires récurrentes (apparaissent à une autre cellule, → dysplasie à long terme)

→ caractères tumoraux limités à l'épithélium (Prolif, Anisplasie, Anisplasie; des différencies...) → Ne franchit pas la barrière!

Exemple: HPV → \$ des oncogènes E6, E7 → altère p53, Rb (Oncogène: HPV 16 = B)

Epithélium → Dysplasie de bas grade, qui à la base de l'épithélium que les \$ basale

→ D. Haut grade = Carcinome In situ = Toute l'épaisseur de l'épithélium de Surface

Dysplasie bas grade → Haut grade → Carcinome In Situ

→ Carcinome Basal qui ne franchit pas la barrière basale = N'arrête PAS BTC

! Une dysplasie n'est même pas forcément un K

Phase Invasive Local

= franchit MB (Maligne basale) → TC

Molécule Adhésion Cellulaire : diminution des jonctions N & (ou des jonctions)

→ Dégénération MEC : pas de Tumeur + \$ atypie (MMP: Métalloprotéase Matricielle)

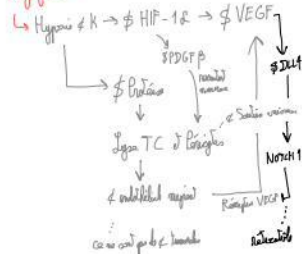
→ Migration: pseudopodes + \$ atypie + \$ chimiotactique. ... R^o Inflammation importante (m peut franchir)

Carcinome In Situ → Carcinome Micro-invasif - R^o inflammation autour

Phase Extensive Local-Région

→ toutes les agenes / tumeurs voisines

Angiogenèse



→ non contrôlé MMS chronique

Phases Critiques = Mécanismes

Invasion de la MEC locale : Système d'apoptose important pour la vascularisation

↳ **Intravasation** : Sait au sein de la tumeur (non-angiogénique) ; Sait épitopique lymphatique

↳ **Survie dans la circulation** (contrôle mécanisme + Tumorale) : ne prolifère pas ! S'agit d'échapper les phagocytes

↳ **Extravasation** : Adhère (E-Sélectine + Integrine) → Rétrécit & adhérent → déstabilise le MBR → TC sans joint

↳ **Invasion métastatique**

↳ **Extension lymphatique** (gros vaisseau → métastase)

Hématogène (Pompe, fuit, cancer → Petit Vaisseau Riche Vascular)

Protège la tumeur

Adhère aux plaques

Mécanisme



X chromosomes défectueux : Biologie moléculaire → FCV (Tête) → Région (Queue)

Spécificité Immunologique VS K



↳ **Immunologie**

K ne développe trop vite

↳ **Niche tumorale**

Protection tissulaire de collagène

↳ **Résistance à la Lyse**

Son expression Anti-Apoptotique

Son expression Pro-Apoptotique

Dérégulation P53

Mutation FAS → Récepteur de mort actif

↳ **Immuno-évasion** → K ne voit

Dim. l'Antigène

Pat. des activateurs NK

Dim. CMH-1

≠ CMH aux cellules (HLA-G)

↳ **Immuno-suppression**

PD1 > PD1L

CTLA-4 > CD28

CD86 > CD80

Tumeurs Non Épithéliales

↳ **Hématopoïèse myéloïde**

↳ **Leucémie** = cancer → crise de sang / Myélogreffe

↳ **Tumeurs solides** → Biopsie / Excision

↳ **Biologie moléculaire**

Hématopoïèse Myéloïde

↳ **Érythrocyte**
↳ **Polynucléaire**
↳ **Mégacaryocyte**

↳ **LAM** (Leucémie Aigüe Myéloblastique) → Acromélie précurseurs myéloblastes immatures (Myéloblastes) → Sang / Moelle osseuse

↳ **Syndrôme Myélo-prolifératif** → Production excessive & myéloblastes matures (≠ Type)

↳ **Syndrôme Myélo-dysplasique** (Hématopoïèse défectueuse) & sang immature = BLAST → LAM

↳ **Dérégulation**

↳ **Anomalie Régulation** (ne répond pas aux inhibiteurs, mortif, BCL2)

↳ **Anomalie Régulation** avec excès de blastes = < 10% "Blaste" → LAM

↳ **Anomalie Régulation** Sémi-épiploïdique → pas de traitement

↳ **Érythroblastose** avec accumulation de fcs maturationnels (cancer du Pail)

↳ **Leucémie Myéloblastique Chronique (LMC)**

↳ **généralisée**

↳ **chromosome de Philadelphia** (t(9;22) BCR-ABL1)

↳ **Phase chronique** → **Phase avancée** → **Phase terminale**

↳ **Phase chronique** → **Phase avancée** → **Phase terminale**

↳ **Phase chronique** → **Phase avancée** → **Phase terminale**

↳ **Phase chronique** → **Phase avancée** → **Phase terminale**

↳ **Phase chronique** → **Phase avancée** → **Phase terminale**

↳ **Phase chronique** → **Phase avancée** → **Phase terminale**

↳ **Phase chronique** → **Phase avancée** → **Phase terminale**

↳ **Phase chronique** → **Phase avancée** → **Phase terminale**

↳ **Phase chronique** → **Phase avancée** → **Phase terminale**

↳ **Phase chronique** → **Phase avancée** → **Phase terminale**